

**Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Facultad de Medicina
Escuela Profesional de Obstetricia**



**DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR ASOCIADA A EMBARAZOS NO
PLANIFICADOS EN USUARIAS DEL C.S HUASCAR II - 2025**

PROYECTO DE TESIS

Para optar el Título Profesional de Licenciado en Obstetricia

AUTOR:

Saire Espinoza, Nayeli Ivonne

ASESORA:

Barrantes Cruz, Nelly

LIMA-PERÚ

2025

ÍNDICE:

CAPÍTULO I	3
1.1. Planteamiento del problema, delimitación y formulación.....	3
1.2. Objetivos	4
1.3. Justificación	5
1.4. Limitaciones.....	6
CAPÍTULO II	7
2.1. Marco teórico.....	7
2.1.1. Antecedentes.....	7
2.1.2. Bases teóricas.....	9
2.1.3. Definición de términos.....	12
2.2. Formulación de hipótesis.....	12
2.3. Diseño metodológico.....	13
2.3.1. Tipo de estudio	13
2.3.2. Diseño de estudio	13
2.3.3. Población.....	13
2.3.4. Muestra.....	13
2.3.5. Variables	14
2.3.6. Operacionalización de variables	14
2.3.7. Técnica.....	15
2.3.8. Instrumento de recolección de datos	15
2.3.9. Procedimientos.....	16
2.3.10. Análisis de datos.....	16
2.4. Consideraciones éticas.....	16
CAPÍTULO III	17
3.1. Recursos disponibles	17
3.2. Cronograma de actividades	17
3.3. Presupuesto.....	18
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	19
ANEXOS	21

CAPÍTULO I

1.1. Planteamiento del problema, delimitación y formulación

La disfuncionalidad familiar se manifiesta a través de constantes conflictos, conductas inadecuadas y, en numerosas ocasiones, situaciones de abuso (1) Muchos autores consideran que esta problemática dificulta el desarrollo de un ambiente familiar saludable y adecuado. En este contexto, la disfuncionalidad interfiere en la habilidad de la familia para ofrecer respaldo, estabilidad y un ambiente seguro para sus miembros.

La familia tiene una función crucial en la comunidad al promover la salud y el bienestar de cada persona. Cualquier problema en este grupo generará vulnerabilidad en sus miembros afectando negativamente su salud individual. (2) En Latinoamérica, se logra identificar que más del 50 % de las familias son disfuncionales, lo que lo convierte en una problemática de gran escala social. (3,4)

El embarazo no planificado es aquel como su mismo nombre lo dice no ha sido previsto por la pareja, aquellos que no se encuentran esperando un hijo. (5) Muchas mujeres y parejas no desean un embarazo debido a distintos factores como priorizar su desarrollo personal o alcanzar un nivel económico mucho más favorable para mantener y criar con la mayor comodidad posible a un nuevo ser.

Este claramente sigue siendo un desafío significativo para la salud pública que necesita ser tratado. Cada año, 74 millones de mujeres experimentan embarazos no planificados, principalmente en países con medios y bajos ingresos. Estos embarazos pueden tener repercusiones graves que amenazan la vida tanto de la madre como del bebé en gestación, por ejemplo, de la cifra anterior mencionada, se revela la existencia de 25 millones de abortos y 47 mil muertes maternas anuales, lo cual nos muestra el impacto de esta problemática. (6)

En los países en desarrollo, se ha encontrado que el 43% de los embarazos no son planificados, afectando principalmente a mujeres pobres, que viven en zonas rurales y tienen un nivel educativo limitado.

Anualmente, se registran 89 millones de embarazos no planificados, de los cuales 48 millones culminan en abortos, lo que pone de manifiesto las disparidades en el acceso a la educación sexual y a los métodos de planificación familiar. (7)

Entre 2015 y 2019, América del Sur registró un promedio anual de 11,9 millones de embarazos, de los cuales 7,92 millones no fueron planificados. (8) En Perú, según datos de la ENDES 2021, el 52.1% de los nacimientos no fueron planeados en los últimos 5 años. (9)

Este problema se debe a múltiples factores tales como: culturales, biológicos, religiosos, emocionales, ambientales y las relaciones disfuncionales familiares, influyendo en decisiones sexuales de las mujeres y con mayor influencia en las adolescentes, lo que destaca la gran importancia del papel familiar dentro de la salud sexual y reproductiva a nivel global. (10) Entre estos factores también destacan el machismo y la falta de empoderamiento femenino, lo que permite que estas prácticas se sigan perpetuando de generación en generación. Por tal se debe trabajar en ello para crear planes de acción y reducir este avance a lo largo del tiempo.

En nuestro país, esta situación representa un desafío tanto social como en el ámbito de la salud pública, la cual si bien existe información sobre el tema, está enfocado principalmente a población adolescente. Además, diversos estudios han demostrado que un bajo nivel socioeconómico está relacionado con la disfuncionalidad familiar, por lo que explorar este campo en un distrito como San Juan de Iurigancho podría proporcionar datos interesantes a través de la formulación de la pregunta ¿Existe asociación entre la disfuncionalidad familiar y embarazo no planificado en usuarias que asisten al área de Atención Prenatal del C.S HUASCAR II?. La cual se buscará responder en este trabajo de investigación.

1.2. Objetivos

Objetivo general

Determinar la asociación entre la disfuncionalidad familiar y el embarazo no planificado en usuarias que asisten al área de Atención Prenatal del C.S HUASCAR II

Objetivos específicos

- Determinar la asociación entre la dimensión de adaptación y el embarazo no planificado.
- Identificar la asociación entre la dimensión participación y el embarazo no planificado.
- Conocer la asociación entre la dimensión desarrollo y el embarazo no planificado.
- Detectar la asociación entre la dimensión afecto y el embarazo no planificado.
- Indagar la asociación entre la dimensión recurso y el embarazo no planificado.

1.3. Justificación

Este estudio tiene como objetivo examinar la situación actual de la problemática planteada y aportar conocimiento sobre cómo influye la disfuncionalidad familiar en la salud sexual y reproductiva.

Existen estudios relacionados al tema pero se enfoca más a una población adolescente. Al tener como población mujeres mayores de edad conoceremos nuevas características en sus relaciones interpersonales y cómo éstas se ven asociadas a un embarazo no deseado.

Esta investigación proporcionará datos significativos que permitirán a los profesionales de la salud sexual y reproductiva en el primer nivel de atención enfrentar este desafío de manera más eficiente.

Este estudio pretende generar nuevos enfoques y estrategias para tratar el embarazo no deseado a través de la creación de guía y protocolos con participación de un equipo multidisciplinario con competencias en salud sexual y reproductiva.

Asimismo, considerando la información, esta investigación contribuirá al empoderamiento de las mujeres en el ámbito social. conforme a la disfuncionalidad familiar y su implicancia en un embarazo no deseado,

tomando lo expuesto como un tema a tratar y mejorar para lograr el cumplimiento de sus derechos reproductivos.

1.4. Limitaciones

- Falta de cooperación de los jóvenes encuestados a la hora de brindar información.
- Sesgo en relación a la veracidad de la información que las participantes puedan brindar

CAPÍTULO II

2.1. Marco teórico

2.1.1. Antecedentes

Vanegas, Diana (México, 2019) publicó un estudio titulado “Factores de riesgo asociados con embarazos no deseados en mujeres estudiantes de medicina”, cuyo objetivo fue examinar los factores de riesgo relacionados con embarazos no deseados en adolescentes. Estudio analítico descriptivo transversal reveló una diferencia estadísticamente significativa en las estudiantes que iniciaron su vida sexual a una edad temprana y su asociación con el embarazo no deseado. Se encontró que el 59.3% de las estudiantes que experimentaron un embarazo no deseado no utilizaron métodos de protección durante su primera relación sexual. Los embarazos no deseados fueron más comunes entre aquellas estudiantes de nivel socioeconómico medio-alto (55.6%) y las que provenían de familias con disfunción de nivel moderado (40.7%). En resumen, los autores concluyeron que el embarazo no deseado se vinculaba a la actividad sexual a temprana edad, siendo la mayoría de estos casos reportados en familias con problemas funcionales moderados y un estatus socioeconómico intermedio. (7)

Loja, Veronica y Villavicencio, Marlon (Ecuador, 2019) publicaron un estudio titulado “Disfuncionalidad familiar y adolescentes embarazadas” cuyo objetivo fue determinar factores de riesgo en las adolescentes embarazadas por una escasa comunicación en el sistema familiar. Estudio descriptivo transversal con el objetivo de describir los factores de riesgo que presentan las adolescentes embarazadas, donde se resalta la ausencia de afecto y comunicación dentro de la dinámica familiar, lo que resulta en que las adolescentes se sientan desprotegidas y busquen llenar estas carencias fuera del círculo familiar, confiando en la pareja. Esto ocasiona que inicien actividades sexuales tempranamente, creyendo haber encontrado un cariño incondicional. (11)

Sari, Oktay; Furkan, Basri y Kemal, Yaşam (Turquía, 2021) publicaron un estudio titulado “Planned and unplanned pregnancy and its association with coping styles and life quality” con el objetivo de comparar a mujeres con embarazos planificados y no planificados en calidad de vida y actitud de afrontamiento. Estudio cuantitativo correlacional longitudinal que dio como resultado que el 74% de las gestantes planificaron su embarazo, quienes en su mayoría afirmaron tener apoyo y un adecuado nivel económico; y el 44% no lo planificaron, encontrándose que la mayoría de ellas estaba expuesta a algún tipo de violencia. (12)

Auquilla, Alvaro (Panamá, 2021) publicó un estudio titulado “Funcionamiento familiar en relación con la conducta sexual de riesgo en adolescentes: una revisión integradora de la literatura” cuyo objetivo fue examinar los factores que influyen en la funcionalidad familiar y su conexión con los comportamientos sexuales de riesgo en jóvenes. A través de un enfoque cualitativo y una revisión sistemática, el estudio concluyó que un entorno familiar desfavorable, marcado por la falta de unión entre los integrantes, escasez de afecto, estilos de crianza que oscilan entre lo permisivo y lo autoritario, así como una supervisión parental deficiente, se relaciona significativamente con un aumento en los embarazos adolescentes, infecciones de transmisión sexual y uso inadecuado de métodos anticonceptivos. (13)

Mendoza, Marleny y Quispe, Yolanda (Perú, 2021). Publicaron un estudio titulado “Funcionalidad familiar en gestantes adolescentes. Hospital Regional de Ayacucho. Diciembre 2019 a Marzo 2020” con el objetivo principal evaluar el grado de funcionalidad familiar en adolescentes que se encontraban en estado de gestación, analizando diversas dimensiones de la dinámica familiar. Estudio cuantitativo de corte transversal, en el cual se reveló que un 46% de las adolescentes embarazadas provenían de familias con una disfunción severa. En cuanto a las distintas dimensiones familiares evaluadas, los resultados mostraron impactos significativos: la participación familiar se situó en un 44%, el crecimiento en un 36%, los recursos familiares alcanzaron un 40%, y el afecto se evidenció en un 52%. Por otro lado, la dimensión de adaptación presentó un nivel moderado, con un 46%.

A partir de estos hallazgos, los autores concluyeron que las deficiencias observadas en estas dimensiones estaban estrechamente relacionadas con la gestación durante la adolescencia, sugiriendo que un entorno familiar disfuncional podría ser un factor determinante en este fenómeno. (14)

Bardales, Diana (Perú, 2022) publicó un estudio titulado “Funcionalidad familiar y las conductas sexuales de riesgo en estudiantes del nivel secundario de una institución educativa en Ancón, 2021” cuyo objetivo fue analizar la correlación entre la funcionalidad familiar y los comportamientos sexuales de riesgo en alumnos de secundaria. Este estudio, de enfoque cuantitativo y diseño transversal, reveló que el 34% de la muestra presentaba una funcionalidad familiar moderada, lo que evidenció una tendencia positiva hacia la unión familiar. Además, entre el 69% y el 75% demostraron estar informados acerca de la manera adecuada de utilizar métodos anticonceptivos y la prevención de embarazos en la adolescencia. En conclusión, aunque no se halló una correlación significativa entre la disfuncionalidad familiar y el embarazo en adolescentes, se demostró que un buen funcionamiento familiar puede actuar como un factor de protección contra comportamientos sexuales de riesgo. (15)

Navarro, Sandra (Perú, 2022) publicó un estudio titulado “Características de la familia y el embarazo adolescente en el centro de salud tumán, 2022” con el objetivo de investigar la relación existente entre las características familiares y el embarazo en adolescentes. Estudio cuantitativo de corte transversal indica que un 41% de las madres adolescentes vivían con sus familias, lo que sugiere una correlación entre la convivencia familiar y el embarazo. Sin embargo, no se encontraron antecedentes relevantes de embarazos precoces en el contexto familiar de las participantes. En cuanto a la educación sexual, se observó que la mitad de las encuestadas declararon haber recibido información principalmente de sus amigos, lo que resalta la falta de comunicación sobre este tema en el entorno familiar. Estos hallazgos subrayan la importancia del apoyo parental señalando que un entorno familiar positivo es crucial para enfrentar las dificultades

relacionadas con el embarazo, sugiriendo el fortalecimiento de los vínculos familiares. (16)

2.1.2. Bases teóricas

Familia:

La medicina familiar y comunitaria entiende a la familia como la unidad fundamental de la sociedad. A lo largo del tiempo, la estructura familiar ha evolucionado desde la tradicional (familia nuclear y extendida) hacia un sistema social flexible, integrado por miembros que generalmente conviven y comparten un espacio, sin importar su tamaño o composición. Es fundamental que ellos atiendan las necesidades esenciales de cada persona y que se prepare a los más jóvenes para su transición a la vida adulta y su incorporación en la comunidad. (17)

Disfuncionalidad Familiar:

En cuanto al funcionamiento de la familia, ha sido comprobado por diversos estudios que este no puede darse de forma completamente estable y fija, ya que existen diversos aspectos que pueden afectarlo, causando la disfuncionalidad familiar. Esta se va a caracterizar por conflictos, conductas inadecuadas, provocando el abuso continuo cometido por los miembros, lo que provoca que los otros individuos normalicen estos actos inaceptables (18)

Por lo tanto, se puede decir que la disfuncionalidad familiar se traduce en el incumplimiento de funciones bases para la familia. (19)

Adaptación:

Es la dimensión que define la capacidad del sistema familiar para adaptarse y, por lo tanto, alterar sus estructuras internas, que incluyen su equilibrio de poder, la igualdad y jerarquía, cómo cada uno de sus miembros juega un papel en las actividades del sistema y, finalmente, las normas que rigen su interacciones. Le otorga la capacidad al sistema para responder de manera efectiva a la tensión y, particularmente, a las tensiones contingentes de una situación dada. El sistema, por lo tanto,

variará su respuesta según la etapa de desarrollo de la familia. Le permite manejar las tensiones en cada etapa con flexibilidad.

Participación:

Se refiere al tipo de dinámica familiar en la que cada persona siente que pertenece y es incluida en el grupo familiar. Sus miembros participan en actividades diarias que puedan ser aparentemente simples, como actividades domésticas y momentos de recreación, pero también en decisiones sobre cosas que le importan al núcleo familiar. Esta forma de interacción fomenta una cohesión familiar donde cada miembro se siente valorado y escuchado, y parte activa de la familia en cualquier aspecto, y los expone a un ambiente de apoyo.

Gradiente de recursos

Conocido también como crecimiento, este proceso implica fomentar la maduración de cada uno de los miembros de una familia, tanto física como emocional. Este es un desarrollo propulsado por el apoyo y el respaldo mutuo dentro de la familia nuclear, facilitando con éxito, avances y movimientos a sus miembros a la total madurez. Además, la comunicación efectiva y abierta también desempeña un papel significativo en este proceso, ya que ayuda a desarrollar lazos en la familia. A través de la creación de un ambiente comprensivo y confiado. Además, guiar a individuos en su autorrealización y su máximo potencial logrado en el contexto familiar es otro papel jugado por esta dimensión.

Afectividad:

Se la considera una de las necesidades más esenciales en cualquier vida humana, ya que implica la forma en que los miembros de la familia intercambian el amor y el afecto. Por lo general, el aprecio y el amor se expresan a través de la forma en que las personas se abrazan, expresan palabras de aliento a sus seres queridos y dan servicios de cuidado y apoyo. Si se expresa de una manera recíproca y genuina, el amor y el afecto serán fundamentales para el fortalecimiento de las relaciones familiares. La demostración del aprecio crea un ambiente lleno de

confianza y asegura a cada individuo pertenencia, lo que es importante para la cohesión familiar y el desarrollo emocional.

Capacidad resolutive:

Se trata del compromiso que cada integrante de la familia asume para dedicar tiempo y atención a satisfacer las necesidades tanto físicas como emocionales de otros miembros del núcleo familiar. Esta responsabilidad implica no solo brindar apoyo y cuidado, sino también contribuir al bienestar compartido mediante la distribución de recursos, como los ingresos económicos, y el uso de los espacios comunes en el hogar. Este acto de cuidado mutuo fortalece las relaciones familiares, promoviendo un ambiente de colaboración y respeto en el que todos participan para asegurar el equilibrio y la estabilidad de la familia.

Embarazo

El término embarazo se refiere al periodo en el que un feto se desarrolla dentro del útero o vientre de una mujer. Este proceso suele tener una duración de alrededor de 40 semanas, lo que equivale a un poco más de 9 meses, contando desde la última menstruación hasta el momento del parto. (20)

Planificación familiar:

Es una estrategia simple y eficaz, diseñada para ayudar a las familias en la adopción de conductas reproductivas apropiadas, facilitándoles lograr sus objetivos de crecimiento personal de la forma más óptima. Además, su objetivo no se limita únicamente a prevenir embarazos no planificados, sino que también ayuda a prevenir abortos provocados y reducir la mortalidad materna (21)

2.1.3. Definición de términos

Disfuncionalidad familiar: Se trata de un entorno en el que los conflictos y el abuso son frecuentes y se presentan de forma continua, lo que lleva a otros integrantes a adaptarse y a aceptar estas conductas como normales. (22)

Embarazo no planificado: También denominado no deseado, son aquellos que ocurren de manera inesperada tanto por relaciones sexuales no consensuadas como por la falla de métodos anticonceptivos. (23)

2.2. Formulación de hipótesis

Ho: No existe la asociación entre la disfuncionalidad familiar y los embarazos no planificados en usuarias que asisten al área de Atención Prenatal del C. S. HUASCAR II.

H1: Existe asociación significativa entre la disfuncionalidad familiar y los embarazos no planificados en usuarias que asisten al área de Atención Prenatal del C. S. HUASCAR II.

2.3. Diseño metodológico

2.3.1. Tipo de estudio

El estudio tendrá un enfoque Analítico Correlacional Transversal no experimental, ya que los resultados de la relación entre variables estudiadas serán medibles y no se manipularon, además de ser tomadas en un tiempo determinado.

2.3.2. Diseño de estudio

Este es un estudio de diseño observacional, ya que se basará en los datos encontrados en la población sin realización de alguna intervención.

2.3.3. Población

Usuarias madres o gestantes adultas que asisten al área de Atención Prenatal del C. S. HUASCAR II. Diciembre 2025

2.3.4. Muestra

Se toma un número de población de 170 usuarias atendidas durante el mes de Junio 2025 en el área de atención prenatal del Centro de Salud. Aplicando la fórmula:

$$n = \frac{N Z^2 p q}{d^2 (N - 1) + Z^2 p q}$$

Nos da un tamaño de muestra de 118. Además de ello se han considerado los siguientes características como criterios de inclusión:

DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR ASOCIADA A EMBARAZOS NO PLANIFICADOS EN USUARIAS QUE ASISTEN AL ÁREA DE ATENCIÓN PRENATAL DEL C.S. HUASCAR II	
POBLACIÓN DE ESTUDIO	USUARIAS QUE ASISTEN AL ÁREA DE ATENCIÓN PRENATAL DEL C.S. HUASCAR II
CRITERIOS DE SELECCIÓN	Inclusión: - Mujeres mayores 18 años - Usuarias en el área Atención prenatal - Usuarias madres o gestantes - Usuarias que hayan tenido embarazo(s) no planificados
	Exclusión: - Mujeres que tengan alguna discapacidad. - Mujeres que no desean participar del estudio
UNIDAD DE ANÁLISIS	Muestra de mujeres usuarias del C. S. Huascar II que acuden a área de atención prenatal, quienes contestaran un cuestionario sobre disfuncionalidad familiar y violencia de pareja.

2.3.5. Variables

Independiente: Disfuncionalidad Familiar

Dependiente: Embarazo no deseado

2.3.6. Operacionalización de variables

Variable	Definición	Dimensión	Indicadores	Tipo	Escala
DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR	Familia en la que los conflictos, la conducta inapropiada y, en ocasiones, el abuso por parte de sus integrantes ocurren de manera constante.	Funcionalidad familiar	ADAPTACIÓN	Cualitativa	Ordinal
			PARTICIPACIÓN		
			AFECTIVIDAD		

			RECURSOS O CAPACIDAD RESOLUTIVA		
			GRADIENTE DE RECURSOS		
EMBARAZO NO PLANIFICADO	Se considera a todo embarazo que no quería o lo quería en un momento posterior	Planificación	Factores internos (Edad, grado de instrucción, pareja, padres)	Cualitativa	Nominal
			Decisión		
			Uso de método anticonceptivo		Dicotómica

2.3.7. Técnica

Encuesta realizada a las participantes que cumplen con los criterios de inclusión.

2.3.8. Instrumento de recolección de datos

Escala de APGAR familiar (modificado)

El APGAR familiar es un instrumento utilizado en diversos centros de salud para evaluar de manera integral el funcionamiento o disfunción de la familia. Este método examina cinco dimensiones fundamentales que se consideran esenciales: Adaptación, Participación, Gradiente de recursos, Afecto y Recursos. Cada dimensión incluye cinco preguntas, y las respuestas se puntúan del 0 al 4, según la frecuencia con que se presentan las situaciones descritas, clasificándose en nunca, casi nunca, algunas veces, casi siempre y siempre. Las puntuaciones totales permiten categorizar el estado familiar en cuatro niveles: Normal (17-20 puntos), disfunción leve (16-13), disfunción moderada (12-10) y disfunción severa (9 o menos).

Además de ello se agregaron ítems adicionales para la recolección de datos sobre el embarazo. Este cuestionario fue sometido a juicio de expertos para posteriormente hacerse una prueba piloto lo que permitirá mejorar este cuestionario para su uso en esta investigación.

2.3.9. Procedimientos

Se presentará un documento al Centro de Salud Huascar II para obtener los permisos correspondientes para acceder al servicio de obstetricia del establecimiento y presentar el cuestionario a las usuarias. Posteriormente, se entregará la encuesta de manera conveniente para completar la muestra, considerando los criterios de inclusión y exclusión establecidos para la población en cuestión. La encuesta se aplicará de forma presencial, donde se realizará una breve presentación y luego se brindará el consentimiento informado a las participantes. Una vez obtenido su consentimiento, procederán con el llenado del cuestionario para su posterior análisis, estando presente la investigadora para esclarecer dudas.

2.3.10. Análisis de datos

Los datos obtenidos en los cuestionarios fueron trasladados al programa Google Sheets y al programa SPSS versión 26. Los resultados se presentaron en gráficos y tablas para realizar un análisis descriptivo de las variables del estudio, así como un análisis inferencial que evaluó la relación entre la disfuncionalidad familiar y los embarazos no planificados. Para este análisis, se aplicó la prueba de chi cuadrado con un nivel de confianza del 95%.

2.4. Consideraciones éticas

Para llevar a cabo el estudio, fue necesario obtener la autorización del Centro de Salud Huascar II, así como el consentimiento informado de las participantes. Durante todo el proceso de investigación, se consideró fundamental respetar a las participantes, por lo que se les informó previamente sobre el estudio. Además, se garantizaron los principios de autonomía, justicia y beneficencia, asegurando la confidencialidad. Los

datos recogidos se utilizaron exclusivamente para los propósitos de esta investigación, y ninguna persona ajena al proyecto o no autorizada tuvo acceso a ellos

CAPÍTULO III

3.1. Recursos disponibles

Para este trabajo de investigación se dispone de: Personal de recolección de datos, internet, electricidad, análisis estadístico, alimentación, pasaje, laptop, impresora, tinta, hojas bond A4, encuadernado y material de escritorio

3.2. Cronograma de actividades

Actividades	Cronograma							
	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril
Planificación								
Búsqueda de información								
Elaboración del proyecto								
Presentación a autoridades								
Aprobación del proyecto								
Ejecución								
Estudio piloto								
Validación de instrumentos								
Recolección de datos								
Digitación de datos								
Análisis de datos								
Comunicación								
Elaboración del informe								
Presentación del informe								
Aprobación								
Sustentación de la tesis								
Publicación								

3.3. Presupuesto

Descripción	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
Recursos Humanos			
Personal de recolección de datos	2 meses	60	120
Subtotal	120		
Servicios			
Internet	7 meses	75	525
Electricidad	7 meses	89	623
Análisis estadístico	1 mes	30	300
Alimentación	7 meses	12	84
Pasaje	1 mes	1	30
Subtotal	1562		
Bienes			
Laptop	1	3000	3000
Impresora	1	800	800
Tinta	4	40	160
Hojas bond A4	500	20	10000
Encuadernado	1	10	10
Lapicero	1	2	2
Lápiz	1	1	1
Borrador	1	1	1
Liquid paper	1	2	2
Subtotal	13976		
TOTAL	15658		

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. López MEA, Acosta JMZ. Familia disfuncional y el deterioro de la salud psicoemocional. *Dominio Las Cienc.* 18 de agosto de 2021;7(4):731-45.
2. Valencia NN, Rodríguez ZE, Vélez C. Familia y empoderamiento. Una revisión desde la mirada social del dengue. *Univ Salud.* 1 de septiembre de 2021;23(3):272-83.
3. Ordóñez Y, Gutiérrez RF, Méndez E, Álvarez NA, Lopez D, de la Cruz C. Asociación de tipología familiar y disfuncionalidad en familias con adolescentes de una población mexicana. *Aten Primaria.* diciembre de 2020;52(10):680-9.
4. Albán VMP, Zambrano AEJ. Funcionalidad familiar y su relación con la autoestima en adolescentes de la ciudad de ambato [Internet]. *SciELO Preprints*; 2023 [citado 3 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/preprint/view/5945>
5. Belduma KA, Cedeño LI, Chamba MJ. Embarazo no planificado como factor influyente en el rendimiento académico de estudiantes de la Carrera de Enfermería. *Dominio Las Cienc.* 2022;8(Extra 3):255-68.
6. WHO. Un nuevo estudio de la OMS relaciona las altas tasas de embarazos no planificados con las deficiencias de los servicios de planificación familiar [Internet]. [citado 3 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news/item/25-10-2019-high-rates-of-unintended-pregnancies-linked-to-gaps-in-family-planning-services-new-who-study>
7. Vanegas DP, Parrón T, Aranda C, Alarcón R. Factores de riesgo asociados con embarazos no deseados en mujeres estudiantes de medicina. *Gac Médica México.* agosto de 2019;155(4):357-62.
8. Embarazo no planeado y aborto en América Latina y el Caribe | Guttmacher Institute [Internet]. 2022 [citado 3 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://www.guttmacher.org/es/fact-sheet/unintended-pregnancy-and-abortion-latin-america-and-caribbean>
9. ENDES. Perú: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES 2021 [Internet]. [citado 3 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/inei/informes-publicaciones/2982736-peru-encuesta-demografica-y-de-salud-familiar-endes-2021>
10. Arias Gallegos WL, Rivera R, Arias Gallegos WL, Rivera R. Factores asociados al comportamiento sexual de mujeres peruanas entre 15 y 25 años de edad. *Interacciones.* 2021;7:e233.
11. Loja VJ, Villavicencio ML. Disfuncionalidad familiar y adolescentes embarazadas [Internet] [bachelorThesis]. Machala : Universidad Técnica de Machala; 2019 [citado 10 de octubre de 2024]. Disponible en: <http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/15045>
12. Sarı O, Dağcıoğlu BF, Akpak YK, Yerebatmaz N, İleri A. Planned and unplanned pregnancy and its association with coping styles and life quality. *Health Care Women Int.* 2 de noviembre de 2023;44(10-11):1314-24.
13. Guzmán ÁFA. Funcionamiento familiar en relación con la conducta sexual de riesgo en adolescentes: una revisión integradora de la literatura. *Cent Rev Científica Univ.* 11 de noviembre de 2022;11(1):74-90.
14. Mendoza Borda M, Quispe Palomino Y. “Funcionalidad familiar en gestantes adolescentes. Hospital Regional de Ayacucho. Diciembre 2019 a marzo 2020”. 2021 [citado 10 de octubre de 2024]; Disponible en: <http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/4051>
15. Quispe B, Betzabeth D. Funcionalidad familiar y las conductas sexuales de riesgo en estudiantes del nivel secundario de una institución educativa en Ancón, 2021. *Univ Priv Norte* [Internet]. 6 de junio de 2022 [citado 10 de octubre de 2024]; Disponible en: <http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/4732635>
16. Navarro Chiroque SL. Características de la familia y el embarazo adolescente en el Centro de Salud - Tumán, 2022. *Repos Inst - USS* [Internet]. 2024 [citado 10 de

- octubre de 2024]; Disponible en:
<https://repositorio.uss.edu.pe/handle/20.500.12802/12717>
17. Ampudia MKM. Familia: enfoque y abordaje en la atención primaria. *Rev Medica Sinerg*. 1 de septiembre de 2020;5(9):e543-e543.
 18. Sánchez JJS. La disfuncionalidad familiar y su incidencia en los problemas de aprendizaje de los niños de tercer año de educación general básica elemental. *Espirales Rev Multidiscip Investig [Internet]*. 8 de septiembre de 2018 [citado 3 de octubre de 2024];2(20). Disponible en:
<https://www.revistaespirales.com/index.php/es/article/view/341>
 19. Araque Barboza F, Julio Cajar JC, Beltrán de la Rosa E, Hernández Flórez J. Adaptabilidad, Participación, Gradiente de Recursos, Afectividad y Capacidad Resolutiva en el Funcionamiento Familiar. *Rev Búsqueda*. 2023;10(1):1.
 20. NICHD. Información sobre el embarazo | NICHD Español [Internet]. 2020 [citado 10 de octubre de 2024]. Disponible en:
<https://espanol.nichd.nih.gov/salud/temas/pregnancy/informacion>
 21. Gutiérrez M. La planificación familiar como herramienta básica para el desarrollo. *Rev Peru Med Exp Salud Publica*. julio de 2013;30(3):465-70.
 22. Mero PL, Pico AB, Rodríguez ERM, Bello MWA del S. Bajo rendimiento académico en estudiantes y disfuncionalidad familiar. 2015 [citado 10 de octubre de 2024]; Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=368445179014>
 23. Langer A. El embarazo no deseado: impacto sobre la salud y la sociedad en América Latina y el Caribe. *Rev Panam Salud Publica* 113mar 2002 [Internet]. 2002 [citado 10 de octubre de 2024]; Disponible en: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/8688>

ANEXOS

CONSENTIMIENTO INFORMADO

El propósito de esta investigación es determinar la asociación entre la disfuncionalidad familiar y los embarazos no planificados. Esta misma es conducida por Nayeli Ivonne Saire Espinoza estudiante de la Escuela Profesional de Obstetricia de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional mayor de San Marcos.

Para participar de este estudio se le pedirá responder preguntas de una encuesta y esto le tomara menos de 10 minutos de su tiempo. Este cuestionario tiene como propósito evaluar el nivel de disfuncionalidad familiar. Dicha información será útil para los objetivos de la presente investigación, asegurándose la total confidencialidad del caso.

Su participación es totalmente voluntaria y no será obligatorio llenar dicha encuesta si es que no lo desea. Si decides participar en este estudio, responde el cuestionario. Todas las respuestas serán de manera anónima. Todos sus datos serán usados con la mayor confidencialidad y para los fines del estudio.

Si tiene alguna duda durante el desarrollo de la encuesta, usted es libre de formular las preguntas que considere pertinente.

Habiendo leído los párrafos anteriores accede a llenar y entregar este cuestionario dando mi consentimiento para participar en este estudio. Reconociendo que la participación es totalmente voluntaria.

He recibido información sobre el estudio mencionado y leído la información escrita en este documento. teniendo en cuenta que ante cualquier duda o consulta que tenga posteriormente me puedo comunicar al correo nayeli.saire@unmsm.edu.pe

Nombre del paciente

Firma

CUESTIONARIO DEL APGAR FAMILIAR MODIFICADO

A. DATOS SOCIODEMOGRAFICOS

1. ¿Cuántos años cumplidos tienes actualmente?

_____ años

2. ¿Cuál es su grado de instrucción?

a) Primaria ()

Complete ()

b) Secundaria ()

c) Técnico ()

Incomplete ()

d) Universitario ()

3. ¿Cuál es tu estado civil?

a) Soltera ()

b) Conviviente ()

c) Casada ()

4. ¿Con quién(es) vivías antes de embarazarte?

a) Solo con uno de mis padres ()

b) Con ambos padres ()

c) Padres y abuelos ()

d) Padres, Abuelos y más miembros de la familia ()

e) Otros: _____

5. ¿Qué te motivó a tener relaciones sexuales?

a) Decisión propia ()

b) Presión de pareja ()

c) Presión de amigos ()

6. ¿Planificaste tu(s) embarazo(s)?

a) Sí () b) **No** ()

7. ¿Estabas usando algún método anticonceptivo al quedar embarazada?

a) Sí () b) No ()

Para las preguntas a continuación es necesario recordar hechos vividos en tu familia
ANTES DE TU EMBARAZO.

ADAPTACION

1. ¿Cuando estuviste frente a algún problema de salud, has recibido apoyo de tu familia?

a) Nunca ()

b) Casi nunca ()

c) Algunas veces ()

d) Casi siempre ()

e) Siempre ()

2. i_¿Cuándo estuviste frente a algún problema escolar has recibido apoyo de tu familia?

a) Nunca ()

b) Casi nunca ()

c) Algunas veces ()

d) Casi siempre ()

e) Siempre ()

3. i_¿Cuándo estuviste frente a algún problema sentimental (enamorado) has recibido apoyo de tu familia?

a) Nunca ()

b) Casi nunca ()

c) Algunas veces ()

d) Casi siempre ()

e) Siempre ()

4. i_¿Crees que ante un problema buscar ayuda en la familia fue la mejor opción?

a) Nunca ()

b) Casi nunca ()

c) Algunas veces ()

d) Casi siempre ()

e) Siempre ()

5. i_¿Llegaste a resolver los problemas que tenías, con el apoyo de tu familia?

a) Nunca ()

b) Casi nunca ()

c) Algunas veces ()

d) Casi siempre ()

e) Siempre ()

PARTICIPACION

1. Ante cualquier decisión que hayas tomado i_¿Crees que la opinión de tu familia fue importante?

a) Nunca ()

b) Casi nunca ()

c) Algunas veces ()

d) Casi siempre ()

e) Siempre ()

2. i_¿Alguna vez tus padres te han impuesto a tomar una decisión sin consultarte?

a) Nunca ()

b) Casi nunca ()

c) Algunas veces ()

d) Casi siempre ()

e) Siempre ()

3. ¿Ante un problema ocurrido, crees que todos los integrantes de tu familia participaron en su solución?

a) Nunca ()

b) Casi nunca ()

c) Algunas veces ()

d) Casi siempre ()

e) Siempre ()

4. ¿Las decisiones que se tomaban en tu familia, tenían en cuenta tu opinión?

a) Nunca ()

b) Casi nunca ()

c) Algunas veces ()

d) Casi siempre ()

e) Siempre ()

5. ¿Con qué frecuencia era la comunicación entre tú y tu familia?

a) Nunca ()

b) Casi nunca ()

c) Algunas veces ()

d) Casi siempre ()

e) Siempre ()

CRECIMIENTO O DESARROLLO

1. Con qué frecuencia tu familia ha manifestado sus expectativas respecto a tu superación?

a) Nunca ()

b) Casi nunca ()

c) Algunas veces ()

d) Casi siempre ()

e) Siempre ()

2. ¿Tu familia ha aceptado tus deseos de emprender nuevas actividades?

a) Nunca ()

b) Casi nunca ()

c) Algunas veces ()

d) Casi siempre ()

e) Siempre ()

3. Tu familia te ha apoyado emocionalmente en la realización de tus metas?

a) Nunca ()

b) Casi nunca ()

c) Algunas veces ()

d) Casi siempre ()

e) Siempre ()

4. Tu familia te ha apoyado econ6micamente en la realizaci6n de tus metas?

a) Nunca ()

b) Casi nunca ()

c) Algunas veces ()

d) Casi siempre ()

e) Siempre ()

5. Con que frecuencia tu familia te ha guiado para enfrentar de una forma correcta las diferentes etapas de tu vida?

a) Nunca ()

b) Casi nunca ()

c) Algunas veces ()

d) Casi siempre ()

e) Siempre

AFFECTO

1.1., Te satisface la forma en que tu familia responde ante tus emociones, como rabia, tristeza o amor?

a) Nunca ()

b) Casi nunca ()

c) Algunas veces ()

d) Casi siempre ()

e) Siempre ()

2.1., Con que frecuencia la relaci6n afectuosa entre tus padres te satisfizo?

a) Nunca ()

b) Casi nunca ()

c) Algunas veces ()

d) Casi siempre ()

e) Siempre ()

3.1., Con que frecuencia la relaci6n afectuosa entre tu madre y tu te satisfizo?

a) Nunca ()

b) Casi nunca ()

c) Algunas veces ()

d) Casi siempre ()

e) Siempre ()

4.1., Con que frecuencia la relaci6n afectuosa entre tu padre y tu te satisfizo?

a) Nunca ()

b) Casi nunca ()

c) Algunas veces ()

d) Casi siempre ()

e) Siempre ()

5. ¿Con qué frecuencia tus padres te mostraron afecto?

a) Nunca ()

b) Casi nunca ()

c) Algunas veces ()

d) Casi siempre ()

e) Siempre ()

RECURSOS

1. ¿Con qué frecuencia los miembros de tu familia dedican su tiempo para conversar?

a) Nunca ()

b) Casi nunca ()

c) Algunas veces ()

d) Casi siempre ()

e) Siempre ()

2. ¿Con qué frecuencia tu familia dedica un tiempo para la recreación?

a) Nunca ()

b) Casi nunca ()

c) Algunas veces ()

d) Casi siempre ()

e) Siempre ()

3. ¿Te satisface como compartían el dinero entre los miembros de tu familia?

a) Nunca ()

b) Casi nunca ()

c) Algunas veces ()

d) Casi siempre ()

e) Siempre ()

4. ¿Te complace los espacios de la casa que se compartían en familia?

a) Nunca ()

b) Casi nunca ()

c) Algunas veces ()

d) Casi siempre ()

e) Siempre ()

5. ¿Te satisface el tiempo que compartían en familia?

a) Nunca ()

b) Casi nunca ()

c) Algunas veces ()

d) Casi siempre ()

e) Siempre ()

Certificado de validez de contenido del instrumento de recolección de datos

No	TIEMS	Pertinencia		Relevancia		Claridad		Sugerencia
		Si	No	Si	No	Si	No	
1	Edad	x		x		x		
2	¿Cuál es su grado de instrucción?	x		x		x		
3	¿Cuál es tu estado civil?	x		x		x		
4	¿Qué lugar ocupas entre tus hermanos?	x		x		X		
5	¿Planificaste tu(s) embarazo(s)?	x		x		X		
6	¿Con quien(es) vivías antes de embarazarte?	x		x		X		
7	¿Qué te motivó a tener relaciones sexuales?	x		x		X		
8	¿Cuando estuviste frente a algún problema de salud, has recibido apoyo de tu familia?	x		x		X		
9	¿Cuando estuviste frente a algún problema escolar has recibido apoyo de tu familia?	x		x		X		
10	¿Cuando estuviste frente a algún problema sentimental has recibido apoyo de tu familia?	x		x		X		
11	¿Crees que fue la mejor opción de buscar ayuda ante un problema en tu familia?	x		x		X		
12	¿Lograste resolver los problemas que tenías, con el apoyo de tu familia?	x		x		X		
13	Ante cualquier decisión que hayas tomado ¿Crees que la opinión de tu familia fue	x		x		X		

	importante?							
14	tAlguna vez tus padres te han impuesto a tomar una decision sin consultarte?	x		x		X		
15	tAnte un problema ocurrido, crees que todos las integrantes tu familia participaron en su soluci6n?	x		x		X		
16	tlas decisiones que se tomaban en tu familia, tenian en cuenta tu opinion?	x		x		X		
17	tCon que frecuencia era la comunicaci6n entre tu y tus padres?	x		x		x		
18	tCon que frecuencia tus padres han manifestado sus expectativas respecto a tu superaci6n?	x		x		X		
19	/ Tus padres han aceptado tus deseos de emprender nuevas actividades?	x		x		X		
20	/ Tus padres te han apoyado emocionalmente en la realizaci6n de tus metas?	x		x		X		
21	/ Tus padres te han apoyado economicamente en la realizaci6n de tus metas?	x		x		X		
22	tCon que frecuencia tus padres te han guiado para enfrentar de una forma correcta las diferentes etapas de tu vida?	x		x		X		
23	/ Te satisface la forma en que tus padres respondian ante tus emociones, como rabia, tristeza, amor?	x		x		X		
24	tCon qua frecuencia la relacion afectuosa entre tus	x		x		X		

	padres te satisfizo?
25	¿Con qué frecuencia la relación afectuosa entre tu madre y tú te satisfizo?
26	¿Con qué frecuencia la relación afectuosa entre tu padre y tú te satisfizo?
27	¿Con qué frecuencia tus padres te mostraron afecto?
28	¿Con qué frecuencia los miembros de tu familia dedican su tiempo para conversar?
29	¿Con qué frecuencia tu familia dedica un tiempo para la recreación?
30	¿Te satisface como comparten el dinero entre los miembros de tu familia?
31	¿Te complace los espacios de la casa que se comparten en familia?
32	¿Te satisface el tiempo que comparten en familia?

HAY SUFICIENCIA en la cantidad de ítems: Observación: r!..t.y.ra.....

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: Aplicable [☐] Aplicable después de corregir [☐] No aplicable [☐]

NOMBRES Y APELLIDOS DEL JUEZ VALIDADOR: S.L9.'/-<i. !...li(°:!:!!€nsf....3..P-B-#fr.i-.DNI: .. f:/Qf..f_fij')

ESPECIALIDAD DEL VALIDADOR: G. neco -Ob.5/e--/-vq

EMP2+3'16 - !<NE 11/6

;;ELDY-BR' fMEJi
SubGerente deOpe,eciones Centro (!
--r. 1:/t:i:.F!.fd •t(J.fl

1. Pertinencia: El [tern co1respo11de al concepto te6rico formulado.
2. Relevancia: El item es apropiado para representar al componenle o dimensi6n especffica de! constructo.
3. Claridad: Se entiende sin dificultad el enunciado del ftern, es conciso, exacto y directo.

certificado de recolección de datos

Teniendo como base los criterios que se detallan a continuación, se evalúa el instrumento de recolección de datos, por el lado.

Marque con un () si es así, de acuerdo a su opinión como experto.

No	CRITERIOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1	El instrumento propuesto responde al problema de investigación.	X		
2	Las instrucciones son claras y orientadoras para el desarrollo del instrumento.			
3	La estructura del instrumento es adecuada en función a la operacionalización de las variables	X		
4	Los ítems permitan lograr el objetivo del estudio			
5	Los ítems del instrumento responden a la operacionalización de las variables	X		
6	El número de ítems es adecuado	X		
7	Los ítems están redactados en forma clara y concisa	X		
8	Los ítems están redactados en forma entendible a la población en estudio			
9	La redacción de los ítems evita redundancias o repeticiones innecesarias entre ítems	X		
10	La escala numérica propuesta es adecuada	X		

Firma del juez evaluador


EDDY DEL PILAR MENDOZA ZUMAETA
 Sub Gerente de Operaciones Centro (e)
 CNP 27390 - RNC 144

FECHA:

Certificado de validez de contenido del instrumento de recolección de datos

No	ITEMS	Pertinencia		Relevancia		Claridad		Sugerenda.
		Si	No	Si	No	Si	No	
I	Edad	x		x		x		
2	¿Cual es su grado de instrucción?	x		x		x		
3	¿Cual es tu estado civil?	x		x		x		
4	¿Que lugar ocupas entre tus hermanos?	x		x		X		
5	¿Planificaste tu(s) embarazo(s)?	x		x		X		
6	¿Con quien(es) vivias antes de embarazarte?	x		x		X		
7	¿Que te motive a tener relaciones sexuales?	x		x		X		
8	¿Cuando estuviste frente a algun problema de salud, has recibido apoyo de tu familia?	x		x		X		
9	¿Cuando estuviste frente a algun problema escolar has recibido apoyo de tu familia?	x		x		X		
10	¿Cuando estuviste frente a algun problema sentimental has recibido apoyo de tu familia?	x		x		X		
11	¿Crees que fue la mejor opción de buscar ayuda ante un problema en tu familia?	x		x		X		
12	¿Lograste resolver los problemas que tenias, con el apoyo de tu familia?	x		x		X		
13	Ante cualquier decision que hayas tomado ¿Crees que la opinion de tu familia fue	x		x		X		

	importante?						
14	¿Alguna vez tus padres te han impuesto a tomar una decisión sin consultarte?	x		x		X	
15	¿Ante un problema ocurrido, crees que todos los integrantes tu familia participaron en su solución?	x		x		X	
16	¿Las decisiones que se tomaban en tu familia, tenían en cuenta tu opinión?	x		x		X	
17	¿Con qué frecuencia era la comunicación entre tu y tus padres?	x		x		x	
18	¿Con qué frecuencia tus padres han manifestado sus expectativas respecto a tu superación?	x		x		X	
19	¿Tus padres han aceptado tus deseos de emprender nuevas actividades?	x		x		X	
20	¿Tus padres te han apoyado emocionalmente en la realización de tus metas?	x		x		X	
21	¿Tus padres te han apoyado económicamente en la realización de tus metas?	x		x		X	
22	¿Con qué frecuencia tus padres te han guiado para enfrentar de una forma correcta las diferentes etapas de tu vida?	x		x		X	
23	¿Te satisface la forma en que tus padres respondían ante tus emociones, como rabia, tristeza, amor?	x		x		X	
24	¿Con qué frecuencia la relación afectuosa entre tus	x		x		X	

	padres te satisfizo?						
25	¿Con que frecuencia la relación afectuosa entre tu madre y tu te satisfizo?	x		x		X	
26	¿Con que frecuencia la relación afectuosa entre tu padre y tu te satisfizo?	x		x		X	
27	¿Con que frecuencia tus padres te mostraron afecto?	x		x		X	
28	¿Con que frecuencia los miembros de tu familia dedican su tiempo para conversar?	x		x		X	
29	¿Con que frecuencia tu familia dedica un tiempo para la recreación?	x		x		X	
30	/ Te satisface como comparten el dinero entre los miembros de tu familia?	x		x		X	
31	/ Te complace los espacios de la casa que se comparten en familia?	x		x		X	
32	/ Te satisface el tiempo que comparten en familia?	x		x		X	

HAY SUFICIENCIA en la cantidad de items:Observación:

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: Aplicable [x] Aplicable después de corregir [] No aplicable []
 NOMBRES Y APELLIDOS DEL JUEZ VALIDADOR: cynthia Anahy contreras Ayquipa DNI: 42297592
ESPECIALIDAD DEL VALIDADOR: Maestro en gestión en salud



Firma

1. Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.
2. Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo.
3. Claridad: Se entiende sin dificultad el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo.

Certificado de valoración global del instrumento de recolección de datos

Teniendo como base los criterios que a continuación se presentan, el/los abajo firmante/s solicitan dar su opinión sobre el instrumento de recolección de datos presentado.

Marque con una (X) en SI o NO, de acuerdo a su opinión como experto.

NCI	CRITERIOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1	El instrumento propuesto responde al problema de investigación.	X		
2	Las instrucciones son claras y orientadoras para el desarrollo del instrumento.	X		
3	La estructura del instrumento es adecuada en función a la operacionalización de las variables	X		
4	Los ítems permitirán lograr el objetivo del estudio			
5	Los ítems del instrumento responden a la operacionalización de las variables	X		
6	El número de ítems es adecuado	X		
7	Los ítems están redactados en forma clara y concisa	X		
8	Los ítems están redactados en forma entendible a la población en estudio	X		
9	La redacción de los ítems evita redundancias o repeticiones innecesarias entre ítems	X		
10	La escala numérica propuesta es adecuada	X		


 Firma del juez evaluador

FECHA: 9/02/2025

Certificado de validez de contenido del instrumento de recoleccion de datos

N°	ITEMS	Pertinencia		Relevanda		Claridad		Sugerencia
		Si	No	Si	No	Si	No	
1	Edad	x		x		x		
2	i,Cual es su grado de instruccion?	X		X		X		
3	i,Cual es tu estado civil?	x		x		x		
4	IOue lugar ocupas entre tus hermanos?	x		x		X		
5	LPlaniticast tu(s) embarazo(s)?	x		x		X		
6	ICon quien(es) vivias antes de embarazarte?	x		x		X		
7	IOue te motiv6 a tener relaciones sexuales?	x		x		X		
8	ICuando estuviste frente a alg(m problema de salud, has recibido apoyo de tu familia?	x		x		X		
9	ICuando estuviste frente a alg(m problema escolar has recibido apoyo de tu familia?	x		x		X		
10	ICuando estuviste frente a algun problema sentimental has recibido apoyo de tu familia?	x		x		X		
11	ICrees que fue la mejor opción de buscar ayuda ante un problema en tu familia?	x		x		X		
12	Illegaste a resolver los problemas que tenias, con el apoyo de tu familia?	x		x		X		
13	Ante cualquier decision que hayas tornado ICrees que la opinion de tu familia fue	x		x		X		

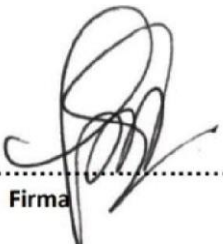
	importante?							
14	¿Alguna vez tus padres te han impuesto a tomar una decisión sin consultarte?	x		x		X		
15	¿Ante un problema ocurrido, crees que todos los integrantes de tu familia participaron en su solución?	x		x		X		
16	¿Las decisiones que se tomaban en tu familia, tenían en cuenta tu opinión?	x		x		X		
17	¿Con qué frecuencia era la comunicación entre tú y tus padres?	x		x		x		
18	¿Con qué frecuencia tus padres han manifestado sus expectativas respecto a tu superación?	x		x		X		
19	¿Tus padres han aceptado tus deseos de emprender nuevas actividades?	x		x		X		
20	¿Tus padres te han apoyado emocionalmente en la realización de tus metas?	x		x		X		
21	¿Tus padres te han apoyado económicamente en la realización de tus metas?	x		x		X		
22	¿Con qué frecuencia tus padres te han guiado para enfrentar de una forma correcta las diferentes etapas de tu vida?	x		x		X		
23	¿Te satisface la forma en que tus padres respondían ante tus emociones, como rabia, tristeza, amor?	x		x		X		
24	¿Con qué frecuencia la relación afectuosa entre tú y tus padres?	x		x		X		

	padres te satisfizo?							
25	/Con que frecuencia la relación afectuosa entre tu madre y tu te satisfizo?	x		x		X		
26	/Con que frecuencia la relación afectuosa entre tu padre y tu te satisfizo?	x		x		X		
27	/Con que frecuencia tus padres te mostraron afecto?	x		x		X		
28	/Con que frecuencia los miembros de tu familia dedican su tiempo para conversar?	x		x		X		
29	/Con que frecuencia tu familia dedica un tiempo para la recreación?	x		x		X		
30	/Te satisface como comparten el dinero entre los miembros de tu familia?	x		x		X		
31	/Te complace los espacios de la casa que se comparten en familia?	x		x		X		
32	/ Te satisface el tiempo que comparten en familia?	x		x		X		

HAY SUFICIENCIA en la cantidad de items:

Observación:

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: Aplicable [x] Aplicable después de corregir [] No aplicable []
 NOMBRES Y APELLIDOS DEL JUEZ VALIDADOR: Janina Da Silva Arevalo DNI: 40375140
 ESPECIALIDAD DEL VALIDADOR: Maestro en gestión en salud



Firma

1. Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.
2. Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica **del** constructo.
3. Claridad: Se entiende sin dificultad el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo.

Certificado de valoración global del instrumento de recolección de datos

Teniendo como base los criterios que a continuación se presentan, le solicito dar su opinión sobre el instrumento de recolección de datos presentado.

Marque con una (X) en SI o NO de acuerdo a su opinión como experto.

No	CRITERIOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1	El instrumento propuesto responde al problema de investigación.	X		
2	Las instrucciones son claras y orientadoras para el desarrollo del instrumento.	X		
3	La estructura del instrumento es adecuada en función a la operacionalización de las variables	X		
4	Los ítems permitirán lograr el objetivo del estudio	X		
5	Los ítems del instrumento responden a la operacionalización de las variables	X		
6	El número de ítems es adecuado	X		
7	Los ítems están redactados en forma clara y concisa	X		
8	Los ítems están redactados en forma entendible a la población en estudio	X		
9	La redacción de los ítems evita redundancias o repeticiones innecesarias entre ítems	X		
10	La escala numérica propuesta es adecuada	X		



Firma de juez evaluador

FECHA: